

GENERALITES SUR L'ENDOSCOPIE DIGESTIVE

Dr BOUHOUCHE.H

Maitre assistant Hépatogastro-Entérologie

**ENDOSCOPIE DIGESTIVE
DIAGNOSTIQUE**

**ENDOSCOPIE DIGESTIVE
THERAPEUTIQUE**

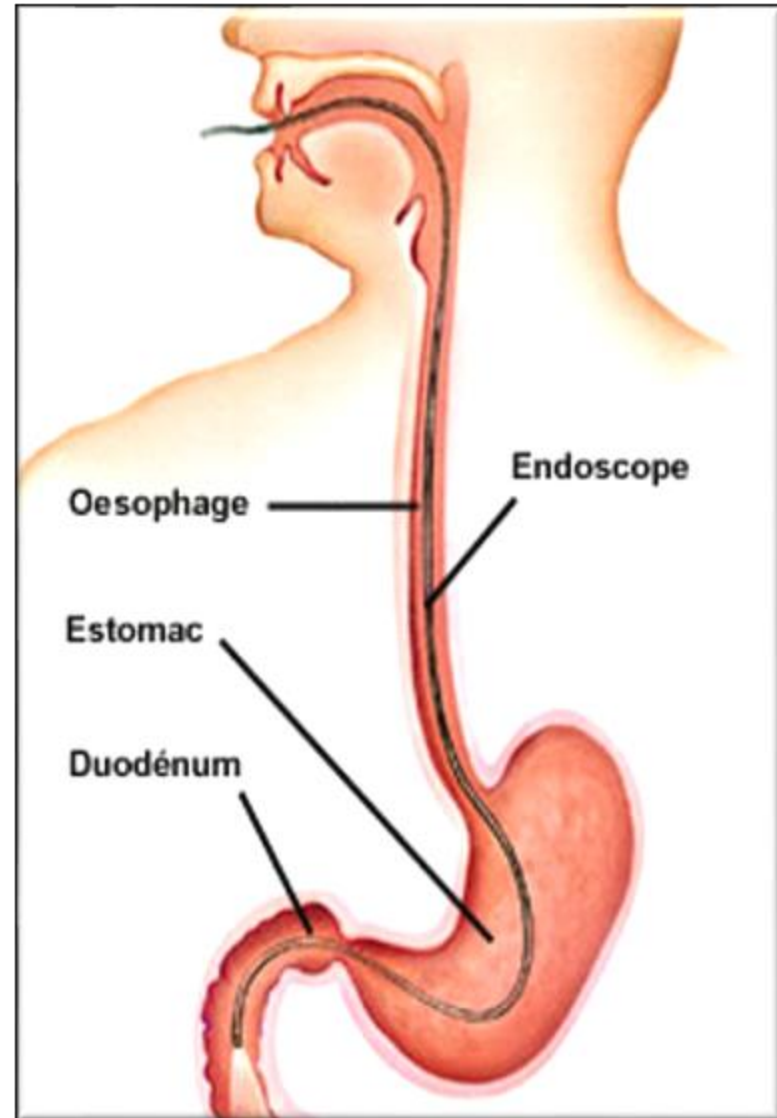
ENDOSCOPIE DIGESTIVE DIAGNOSTIQUE

1. FIBROSCOPIE OESO-GASTRO-DUODENALE
2. ENTEROSCOPIE
3. RECTOSCOPIE
4. COLOSCOPIE
5. VIDEOCAPSULE
6. CHROMOENDOSCOPIE (Chimique/électronique)
7. LATÉROSCOPIE
8. ECHOENDOSCOPIE

FIBROSCOPIE OESO-GASTRO-DUODENALE

Définition

- Examiner directement le tube digestif supérieur : œsophage, estomac et duodénum.
- Faire différents prélèvements.
- D'effectuer divers traitements comme enlever un corps étranger ou un polype ou encore contrôler un saignement par électrocoagulation, etc.
- L'examen dure de 5 à 10 minutes.



Matériel



Fibroscope optique

Fibroscope

- Tube de 100 cm de longueur
- béquillage quadri-directionnel
- canal d'insufflation d'air
- canal pour lavage à l'eau
- canal opérateur : pour aspiration et introduire les instruments.



Vidéo-endoscopie

Indications

- En urgence: HD, caustique , corps étranger...
- Douleurs épigastrique, dysphagie....
- Recherche les signes d'HTP
- Bilan étiologique d'une Anémie inexpliqué...

Contre-indications

- Etat de choc.
- Insuffisance cardiaque ou respiratoire décompensée.
- Perforation digestive
- Troubles de conscience malade non intubé

Déroulement de l'examen

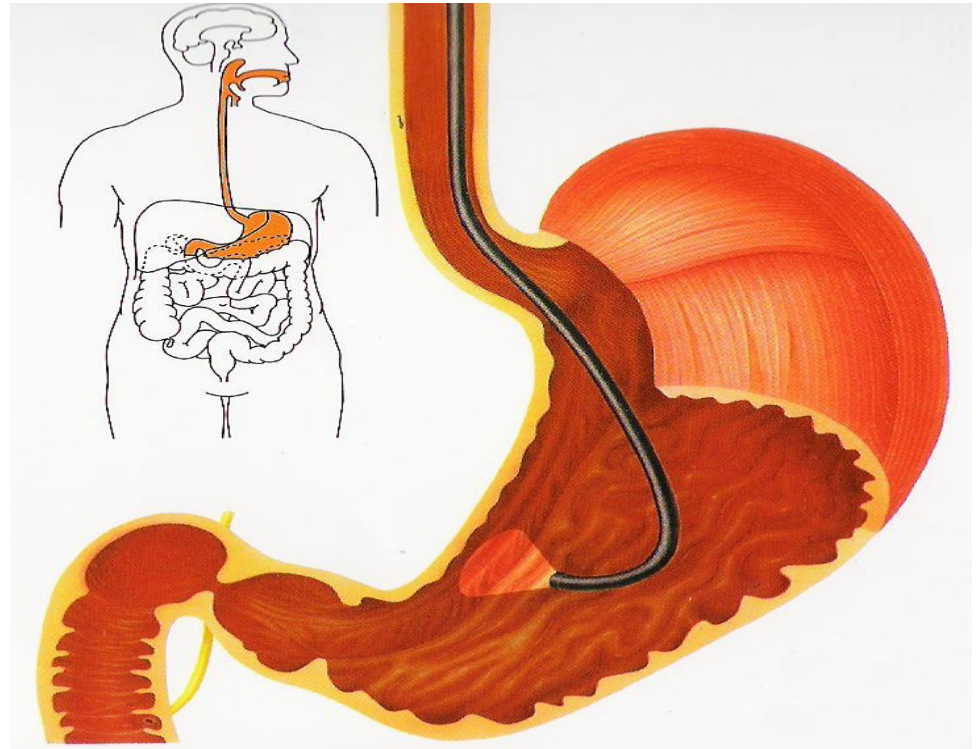
- Estomac vide.
- Jeun de 6 heures.
- Ne pas fumer.
- Informer le médecin:
valvulopathie
TRT anticoagulant
- Enlever ses prothèses dentaires
- DLG, tête légèrement fléchie.
- **Anesthésie locale, AG**



Fibroscopie gastrique
en cours de réalisation

RESULTATS

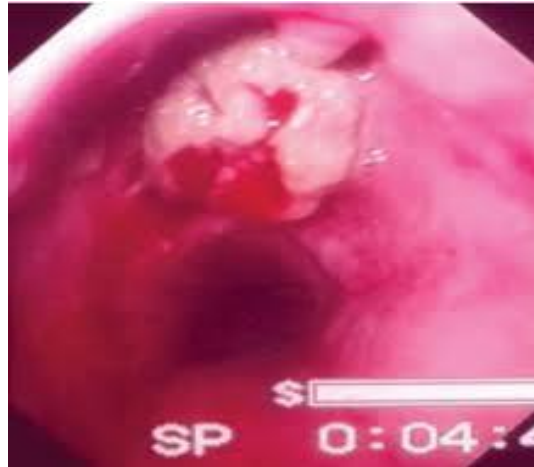
FOGD normale



FOGD pathologique



Varice œsophagienne



KC œsophage



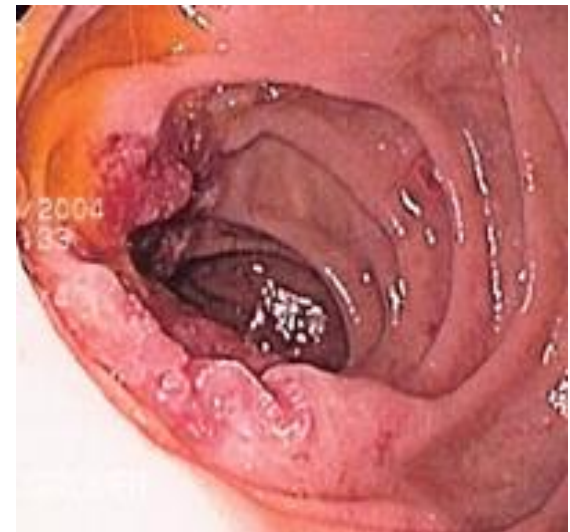
œsophagite peptique



Ulcère bulbaire



Kc gastrique



Kc duodénale

Complications

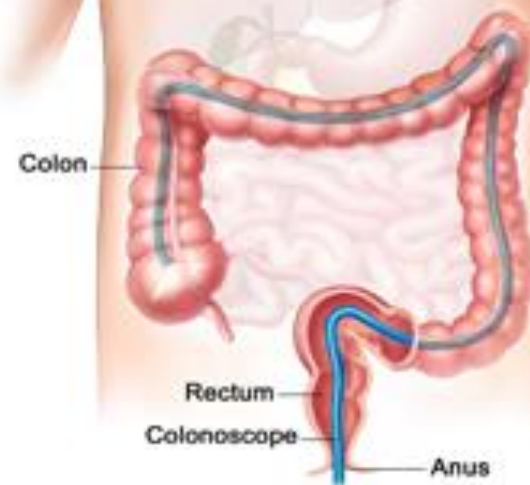
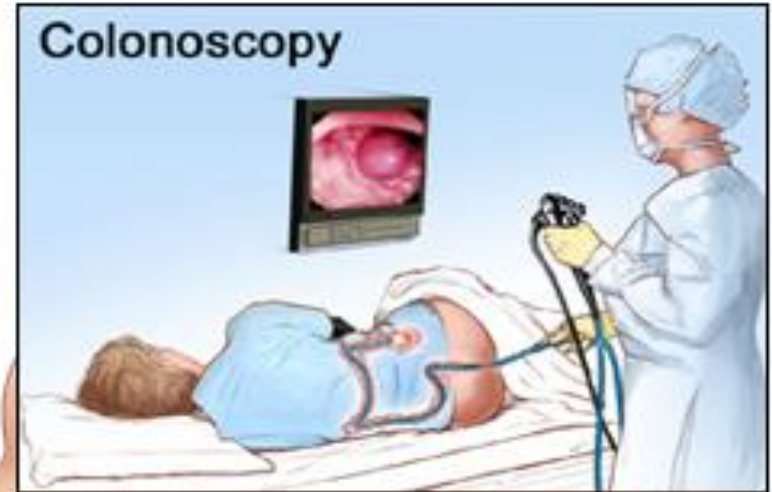
Exceptionnelles

- Pneumopathie d'inhalation
- Perforation
- Hémorragie
- Troubles cardio vasculaires et respiratoires
- Infection

COLOSCOPIE

Définition

- Examiner directement le colon et la dernière anse iléale.
- Faire différents prélèvements.
- D'effectuer divers traitements comme enlever un polype ou encore contrôler un saignement par électrocoagulation, etc.



Matériel



Fibroscope optique

Coloscope

Les même caractéristiques que la FOGD, le diamètre et la longueur sont plus importantes (Tube de 140 - 160 cm de longueur)



Vidéo-endoscopie

Indications

- Trouble de transit
- HD basse
- Douleurs abdominale, syndrome sub-occlusif...
- Dépistage de polypes et de CCR sujets à risques
- Anémie chroniques

Contre-indications

- Etat de choc.
- Insuffisance cardiaque ou respiratoire décompensée.
- Perforation digestive
- Occlusion, colectasie
- Diverticulite aigue

Déroulement de l'examen

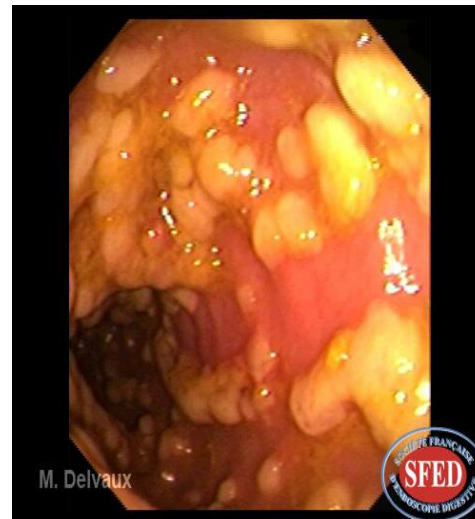
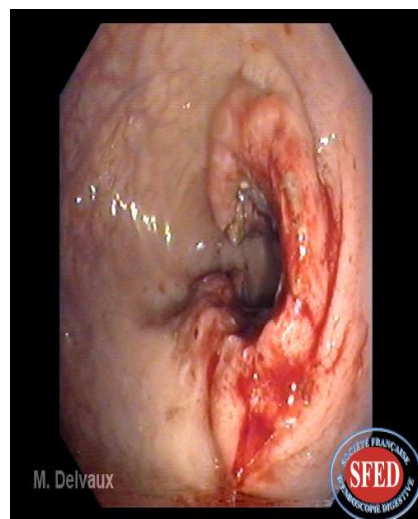
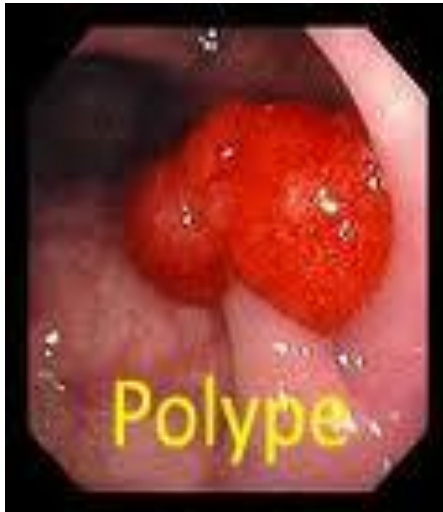
- Arrêt de médicament contenant du fer ou du charbon
- Régime sans résidus 4-5 jours avant
- Ingestion de 4 litres de PEG la veille
- Avec ou sans AG, examen +/- douloureux
- Examen sous contrôle de la vue, l'examen se fait au retrait

RESULTATS

Coloscopie normale



Coloscopie pathologique



Complications

Exceptionnelle

- Perforation
- Hémorragie
- Troubles cardio vasculaires et respiratoires
- Occlusion lors de la préparation

RECTOSCOPIE

Définition

Exploration du rectum, +/- sigmoïde

Matériel

- Un tube rigide contenant un système optique et lumineux
- 15-25 cm

Indications

- Rectorragies
- Trouble du transit
- Proctalgies
- SD dysentérique
- Ecoulement anal....



et un rectoscope
(matériel à usage unique)

Déroulement de l'examen

- Préparation locale
- Position genu-pectorale
- Introduit par l'anus
- Une fois le rectoscope en place, de l'air est insufflé pour déplisser les parois du rectum et permettre une meilleure visualisation de la muqueuse
- Examen sous contrôle de la vue, l'examen se fait au retrait



AUTRES TECHNIQUES ENDOSCOPIQUES

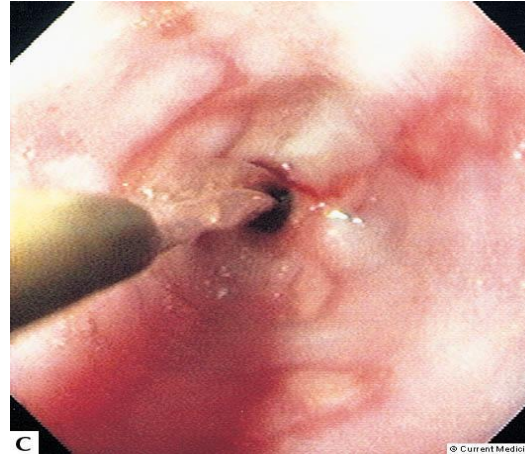
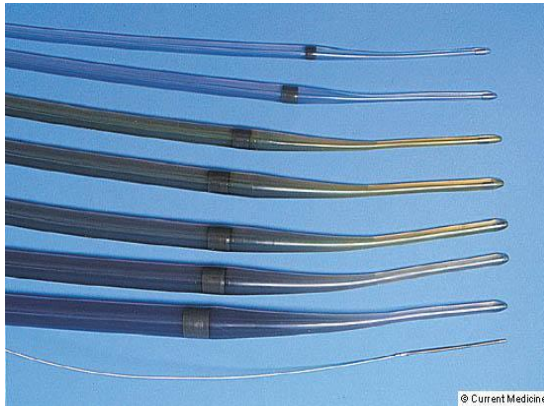
- Entéroscopie
- Vidéo-capsule
- Chromoendoscopie (Chimique/électronique)
- Latéroscopie
- Échoendoscopie

ENDOSCOPIE DIGESTIVE THERAPEUTIQUE

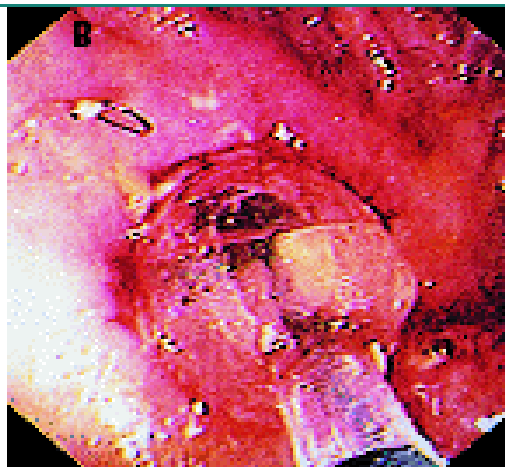
1. DILATATION ENDOSCOPIQUE
2. PROTHESES ENDOSCOPIQUE
3. EXCTRACTION DE CORPS ETRANGERS
4. POLYPECTOMIE ET MUCOSECTOMIE
5. HEMOSTASE ENDOSCOPIQUE
6. TRT INSTRUMENTAL DES HEMORROIDES
7. SPHINCTEROSCOPIE ENDOSCOPIQUE
8. GASTROSTOMIE ENDOSCOPIQUE PERCUTANEE

DILATATION ENDOSCOPIQUE

Dilater une sténose digestive accessible à l'endoscopie (œsophage , pylore , colon ...)



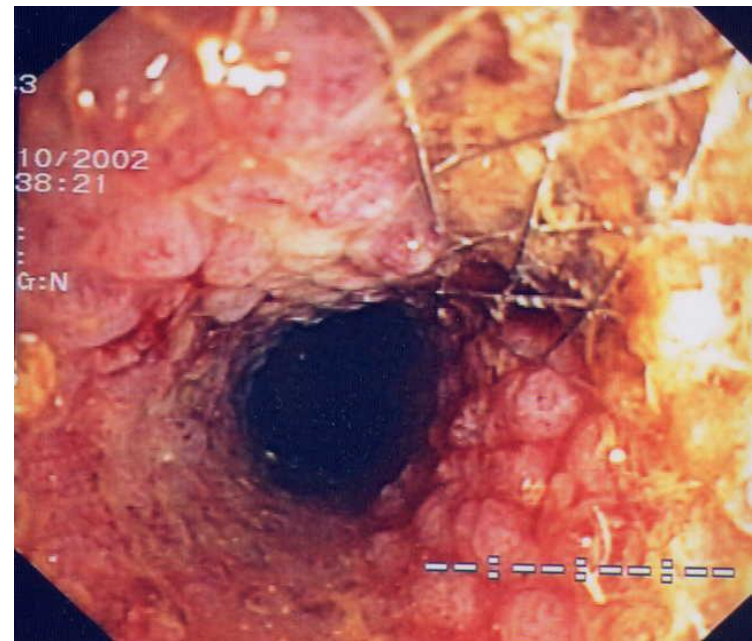
Dilatation par bougies



Dilatation par ballonnets

PROTHESES ENDOSCOPIQUE

Traiter les sténoses digestives ou biliaires bénignes ou malignes



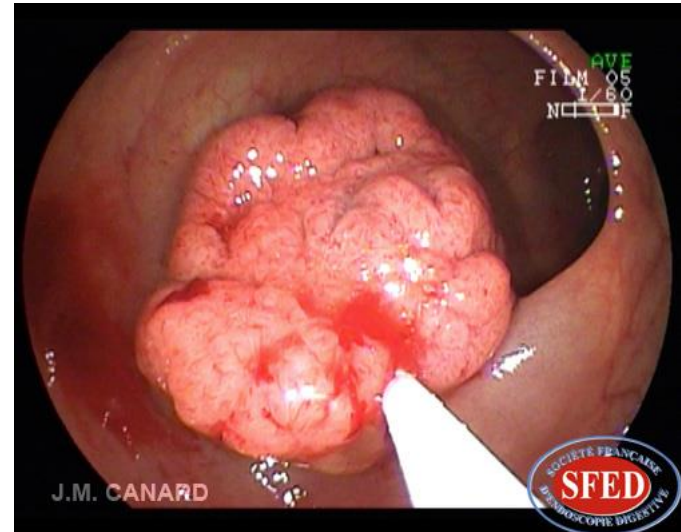
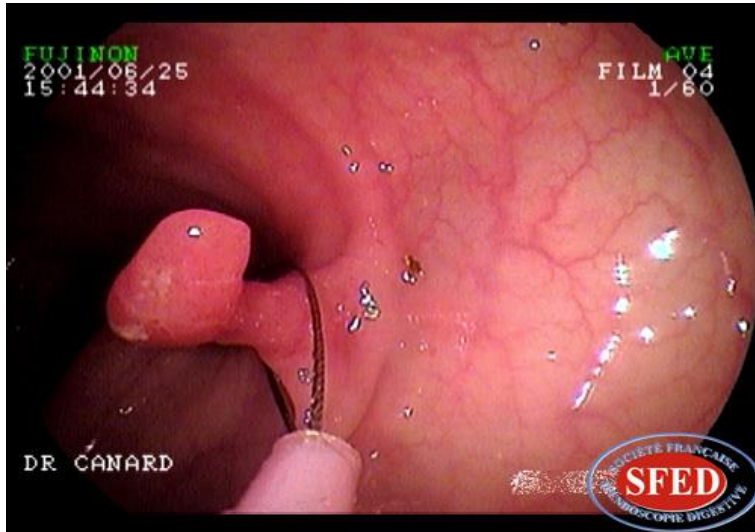
POSE DE PROTHESE COLIQUE

EXTRACTION DE CORPS ETRANGERS



Corps étranger intra-oesophagien

POLYPECTOMIE ET MUCOSECTOMIE



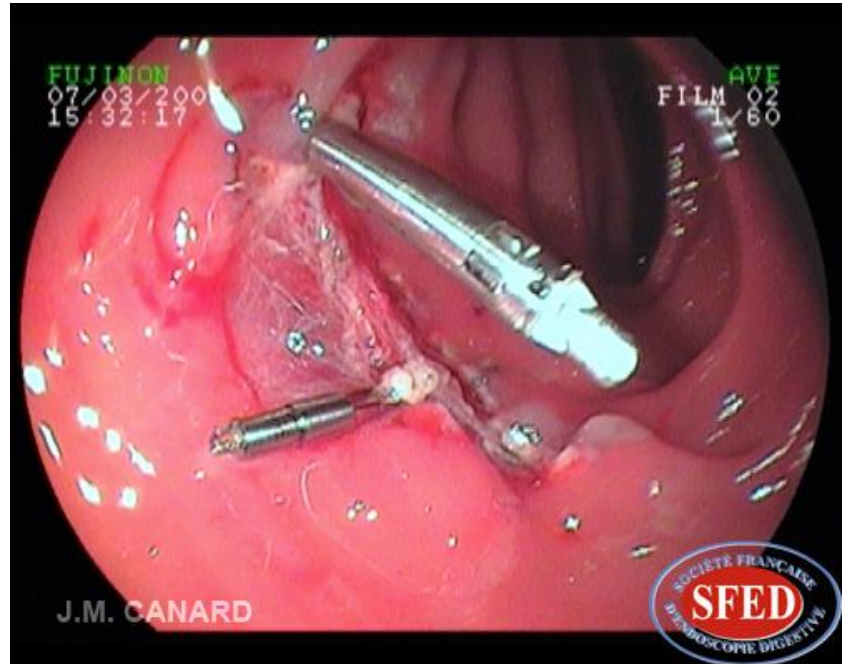
MUCOSECTOMIE

- Exérèse complète des lésions planes ou sessiles de la muqueuse digestive
- Résection du plan sous-muqueux

HEMOSTASE ENDOSCOPIQUE



Ligature élastique de VO



POSE DE CLIPS HEMOSTATIQUES

TRT INSTRUMENTAL DES HEMORROIDES



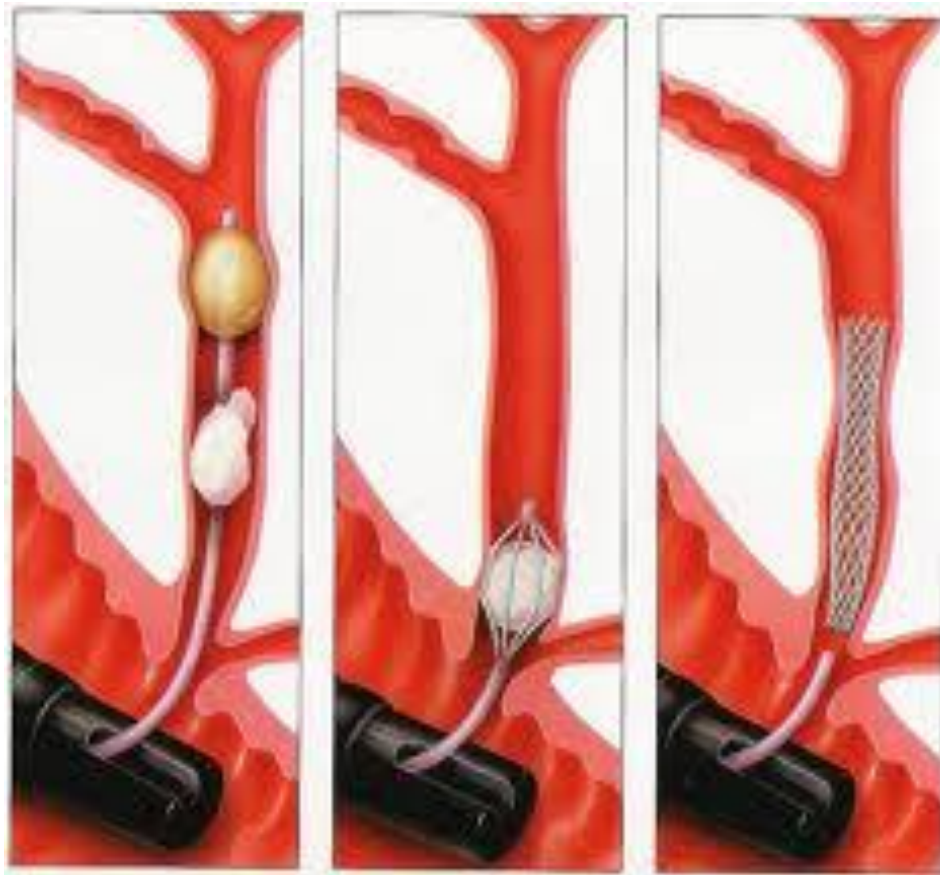
TRT par infrarouge



TRT par ligature élastique

SPHINCTEROSCOPIE ENDOSCOPIQUE

Cholangio-pancreatographie rétrograde endoscopique (CPRE)



GASTROSTOMIE ENDOSCOPIQUE PERCUTANEE

CONCLUSION

- Avancées +++ techniques endoscopiques
- Endoscopie thérapeutique: place de la chirurgie!!!